

○ プラトー圧の上昇や血圧の低下、1回換気量の低下などが起こりうるため慎重にモニタリングを行う。

× 熟練していない施設では有害性が高い可能性があり、一律には推奨されていない。

× ICU 関連筋力低下のリスクとなるため、筋弛緩薬は中等症以上の ARDS 患者において、発症早期に投与期間を 48 時間以内に限定して使用する。

○ 腹臥位療法によって死亡率の改善が期待されるが、褥瘡の増加なども報告されている。実施には熟練した複数のスタッフが必要であり、施設の状況を勘案して判断する。

○ 重度の低酸素血症や、適切な人工呼吸器管理下でも高度のアシデミアを伴う高二酸化炭素血症を呈する場合などでは ECMO を検討する。

× 通常は吸入酸素濃度 60% 以下を目標とする。

○ プロトコル化された離脱によって人工呼吸器使用期間の短縮が期待できる。

× 循環動態が安定している場合、水分を制限した管理が望ましい。ただその指標として明確に定まったものはない。

○

× 感染症の合併が疑われる症例で速やかに使用する。予防的な抗菌薬の使用は推奨されない。

× 副腎皮質ステロイドを投与する場合、ARDS 発症早期において、メチルプレドニゾロン 1~2 mg/kg 相当の使用が推奨されている。

× 質の高いエビデンスは乏しいものの、日本では ARDS の治療薬として保険収載されている。その場合でも、「4 臓器以上の多臓器障害を合併する患者や熱傷・外傷に伴う急性肺障害患者には投与しないことが望ましい」との注釈がある。